

Cetoacidose Diabética

Folha de controle — plantão

Instrumento de apoio à conduta. Não substitui protocolo institucional.

PACIENTE _____

PRONTUÁRIO / LEITO _____

PESO _____ kg IDADE _____ anos

INÍCIO DO TRATAMENTO _____

GRAVIDADE (PIOR PARÂMETRO)	LEVE	MODERADA	GRAVE
pH arterial	7,25–7,30	7,00–7,24	<7,00
Bicarbonato	15–18	10–14	<10
Consciência	consciente	consciente ou rebaixado	estupor ou coma

Diagnóstico: hiperglicemia (>250 mg/dL, ou qualquer valor com iSGLT2) + acidose

(pH <7,30 ou HCO₃[−] <18 mEq/L) + cetose documentada + AG >10 mEq/L.

MONITORIZAÇÃO HORÁRIA — BEIRA-LEITO (A CADA 1 H)

HORA	GLICEMIA CAPILAR	PA	FC	FR	TAX SPO ₂	CONSC. GLASGOW	DIURESE ML	INSULINA UI/H	FLUIDO ML/H	BALANÇO ACUM.	INTERCORRÊNCIA / CONDUTA
H0											
H1											
H2											
H3											
H4											
H5											
H6											
H7											
H8											
H9											
H10											
H11											
H12											

LABORATÓRIO SERIADO — GASOMETRIA E ELETRÓLITOS (A CADA 2–4 H)

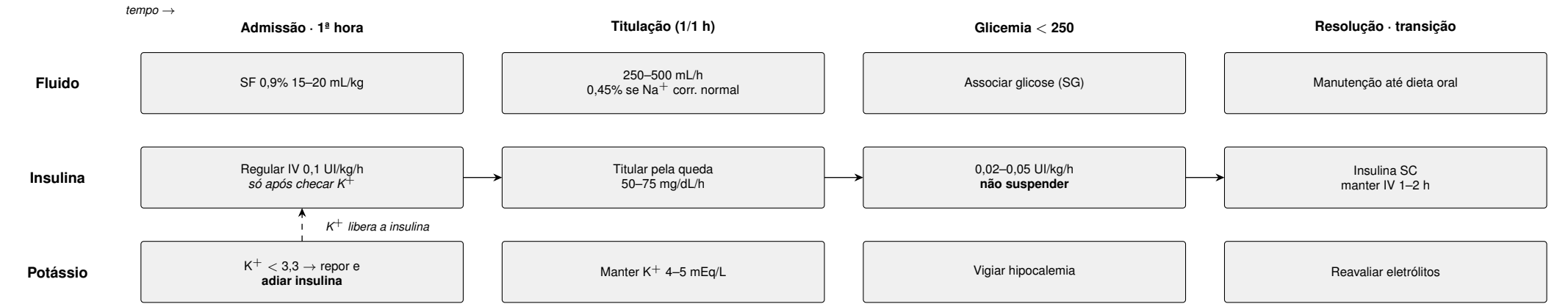
HORA / DATA	PH	HCO ₃ [−] MEQ/L	AG	K ⁺	NA ⁺ (CORRIG.)	CL [−]	CETONEMIA β-OHB	CONDUTA / AJUSTE
H0								
+2 h								
+4 h								
+6 h								
+8 h								
+10 h								
+12 h								

Horária: glicemia capilar, sinais vitais, diurese, insulina e balanço. Laboratório: gasometria venosa, eletrólitos e cetonemia (β-hidroxibutirato) — alvo real da resolução é o ânion gap, não a glicemia. AG e HCO₃ em mEq/L · insulina regular endovenosa (UI/h).

ALGORITMO DE MANEJO — TRÊS LINHAS EM PARALELO NO TEMPO

CONDUTAS INDISPENSÁVEIS

- Dosar potássio **antes** de iniciar insulina. Se K⁺ <3,5 mEq/L: repor e só então infundir insulina.
- Glicemia abaixo de 250 mg/dL **não** significa resolução — manter insulina e associar solução glicosada.
- Resolução exige normalização do **gap aniônico**, não apenas da glicemia.
- Na transição para via subcutânea, manter infusão endovenosa por **2 h** após a primeira dose subcutânea.



REPOSIÇÃO VOLÊMICA
Adulto
1ª hora: SF 0,9% **15–20** mL/kg (máx. **1,5** L)
Manutenção: **250–500** mL/h
Se sódio corrigido ≥135 mEq/L: SF 0,45%
Criança
Expansão: SF 0,9% **10** mL/kg (repetir só se choque)
Volume total: até **1,5–2** vezes o volume de manutenção
Sódio corrigido = Na⁺ + 1,6 × [(glicemia – 100)/100]

INSULINA REGULAR ENDOVENOSA
Adulto: **0,1** UI/kg/h (bolus inicial 0,1 UI/kg, opcional)
Criança: **0,05–0,1** UI/kg/h, após 1 h, **SEM BOLUS INICIAL**
Bomba de infusão
50 UI + 50 mL SF 0,9% ⇒ 1 UI/mL
Desprezar 20 mL do equipo (volume morto)
Taxa: **1 mL/h = 1 UI/h**
Se glicemia <250 mg/dL: **0,05** UI/kg/h + solução glicosada

POTÁSSIO NO SORO

K ⁺	INSULINA	CLORETO DE K
<3,5	NÃO INICIAR	20–40 mEq/h
3,5–5,5	pode infundir	20–30 mEq/L
>5,5	pode infundir	não repor

KCl 19,1%: **7,8** mL/20 mEq 10%: **14,9** mL/20 mEq
Máx. 40 mEq/L em VP. Nunca em bolus endovenoso.

GLICOSE (GLICEMIA < 250 MG/DL)
Two-bag
Duas bolsas de soro em Y, mesma taxa e mesma reposição de K⁺; uma com glicose. Ajustar a mistura conforme a glicemia.
Método convencional
SG 50% **50** mL por frasco de SF ≈ SG 5%; trocar a solução no alvo.
NÃO INTERROMPER INSULINA ENDOVENOSA — associar solução glicosada.

CRITÉRIOS DE RESOLUÇÃO — TODOS NECESSÁRIOS
Glicemia <**200** mg/dL • pH ≥**7,30** • AG ≤**12** mEq/L • **paciente consciente, em dieta oral**
TRANSIÇÃO PARA INSULINA SUBCUTÂNEA
Insulina basal SC → refeição + insulina de ação rápida → **manter endovenosa por 2 h** → suspender bomba → glicemia capilar em 1 h e 3 h

ATENÇÃO — CRIANÇA: EDEMA CEREBRAL
Cefaleia, vômitos, bradicardia com hipertensão arterial, rebaixamento de consciência. Manitol **0,5–1** g/kg ou NaCl 3% **2,5–5** mL/kg. Não adiar neuroimagem.